أنقذ الحالة المتعثرة™ · المكافأة 2

حالات المتابعة الطارئة: حاصرة مكسورة، سلك واخز، جهاز مكسور

25 حالة طارئة تحدث بين زيارات المتابعة: التقييم، والبروتوكول، ونص جاهز يُقال للمريض.

دليل طبيب التقويم

المحتويات

أول 60 ثانية في الحالة الطارئة

فهرس الحالات الـ25

1 · الحاصرة والأنبوب والطوق

2 · السلك والرباط

3 · الألم والأنسجة الرخوة

4 · الغرسة المصغّرة

5 · الجهاز

6 · التثبيت والمصفقات

7 · الرضوض والبلع

نموذج تسجيل الطوارئ

البداية

أول 60 ثانية في الحالة الطارئة

الترتيب نفسه في كل حالة طارئة: السلامة، السبب، الحل، التسجيل.

1. **السلامة:** هل يوجد ضيق تنفس أو نزف أو بلع أو رضّ؟ إن وُجد فابدأ به.
2. **ما الذي انكسر، وما الذي يخز؟** اعثر على القطعة وتأكد من عدم بقاء أي قطعة حرّة في الفم.
3. **هل المريض في أمان؟** أزِل القطعة الواخزة أو الحادّة أو الحرّة.
4. **السبب؟** العضة، الطعام، اللصق، تصميم الجهاز. دوّنه.
5. **القرار:** صحّح الآن، أو أجّل إلى زيارة المتابعة التالية، أو أحِل.
6. **التسجيل:** التاريخ، الحالة، السبب، الإجراء المنفّذ، والمعلومات المقدّمة للمريض.

حالات تستدعي الإحالة الفورية

- اشتباه بلع أو استنشاق مع سعال أو ضيق تنفس أو صعوبة بلع
- رضّ سني: خروج السن من مكانه، كسر، رضّ الفك
- تورّم منتشر، حمّى، إفرازات
- نزف لا يمكن إيقافه

عن النصوص الموجّهة إلى المريض

املأ الحقول **[اسم المريض]** و**[اسم العيادة]** و**[تاريخ الموعد]** ببياناتك. النصوص لأغراض التوعية؛ أرسلها عبر القناة التي تعتمدها عيادتك وبأسلوبك الخاص.

الفهرس

فهرس الحالات الـ25

اعثر على الحالة، وانتقل إلى رقمها.

الرقم	الحالة	المجموعة
01	انفصال حاصرة في سن أمامي	الحاصرة والأنبوب والطوق
02	انفصال حاصرة في سن خلفي	الحاصرة والأنبوب والطوق
03	ارتخاء أنبوب الرحى أو الطوق	الحاصرة والأنبوب والطوق
04	الطرف الوحشي للسلك يخز الخد	السلك والرباط
05	خروج السلك القوسي من الأنبوب	السلك والرباط
06	انكسار السلك القوسي	السلك والرباط
07	طرف سلك الرباط يخز	السلك والرباط
08	فقدان الرباط المطاطي أو السلسلة	السلك والرباط
09	انزياح النابض المفتوح	السلك والرباط
10	الألم والحساسية في الأيام الأولى	الألم والأنسجة الرخوة
11	تقرّح في الخد أو الشفة	الألم والأنسجة الرخوة
12	تهيّج حول الغرسة المصغّرة	الغرسة المصغّرة
13	حركة الغرسة المصغّرة أو سقوطها	الغرسة المصغّرة
14	ارتخاء برغي RME أو انفصال الطوق	الجهاز
15	انفصال القضيب عبر الحنك (TPA)	الجهاز
16	انغراس زرّ Nance في النسيج	الجهاز
17	كسر الجهاز الوظيفي المتحرك	الجهاز
18	انفصال وصلة الجهاز الوظيفي الثابت	الجهاز
19	تهيّج الجلد أو مشكلة في وصلات قناع الوجه	الجهاز
20	انفصال المثبّت اللساني الثابت	التثبيت والمصفّفات
21	كسر المثبّت الشفاف أو Essix أو فقدانه	التثبيت والمصفّفات
22	كسر مثبّت Hawley	التثبيت والمصفّفات
23	سقوط الملحق في علاج المصفّفات الشفافة	التثبيت والمصفّفات
24	رضّ سني لدى مريض بالحاصرات	الرضوض والبلع
25	اشتباه بلع قطعة أو فقدانها	الرضوض والبلع

المجموعة 01

الحاصرة والأنبوب والطوق

3 حالات

الحالة 01 انفصال حاصرة في سن أمامي

التقييم: هل الحاصرة معلّقة على السلك أم انفصلت تمامًا؟ هل يوجد ضرر في سطح السن؟ هل الانفصال بسبب تماس العضة؟

البروتوكول

1. افحص السلك والحاصرة؛ إن لم يكن السلك واخزًا فالمريض في أمان.
2. دوّن سبب الانفصال: العضة، الطعام، سطح اللصق.
3. أعد اللصق أو خطّط له في زيارة المتابعة التالية.
4. إذا تكرر الانفصال في السن نفسه فافحص تماس العضة.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، انفصال الحاصرة عن سنك ليس حالة طارئة. قد تبقى الحاصرة على السلك؛ إن لم تكن واخزة فيُرجى عدم لمسها. سنعيد لصقها في [اسم العيادة] خلال زيارة المتابعة بتاريخ [تاريخ الموعد]. نوصيك بتجنّب الأطعمة الصلبة واللزجة.

متى تكون طارئة: إذا رافقها كسر في السن أو رضّ فقيّمها في اليوم نفسه.

الحالة 02 انفصال حاصرة في سن خلفي

التقييم: هل حاصرة الضاحك تدور على السلك، وهل تحتكّ بالخد؟

البروتوكول

1. إذا كانت الحاصرة الدوّارة تحتكّ بالخد فثبّتها مؤقتًا أو أزِلها.
2. افحص السلك؛ هل الطرف الوحشي واخز؟
3. خطّط لإعادة اللصق.
4. افحص تماس العضة.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد تكون الحاصرة في سنك الخلفي قد انفصلت. إذا كانت تحتكّ بخدك فيُرجى وضع شمع التقويم عليها. سنصحّحها في زيارة المتابعة بتاريخ [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: إذا وُجد تقرّح عميق في الخد أو خطر بلع فموعد مبكر.

الحالة 03 ارتخاء أنبوب الرحى أو الطوق

التقييم: هل يتحرك الطوق على السن؟ هل يوجد تراكم طعام تحت الإسمنت؟

البروتوكول

1. أزِل الطوق، ونظّف السن، وقيّم السطح.
2. أعد تثبيته بالإسمنت أو اختر طوقًا جديدًا.
3. إذا كان مرتبطًا بجهاز (RME، TPA) فافحص سلامته.
4. سجّل الارتخاء في سجل الحالة.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد تكون الحلقة المعدنية حول سنك الخلفي قد ارتخت. يُرجى تنظيف المنطقة بعناية حتى لا يتراكم الطعام.
نوصيك بتقديم موعدك: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: إذا خرج الطوق تمامًا وأصبح الجهاز حرًّا في الفم ففي اليوم نفسه.

المجموعة 02

السلك والرباط

6 حالات

الحالة 04 الطرف الوحشي للسلك يخز الخد

التقييم: كم يبرز السلك من الأنبوب؟ هل طال مع حركة الأسنان (مع إغلاق المسافات)؟

البروتوكول

1. اقطع السلك الزائد؛ وألِّن طرفه أو اثنِه للداخل.
2. تأكّد من عدم بقاء القطعة المقطوعة في الفم.
3. افحص التقرّح في الخد.
4. إذا كانت المسافة تُغلق فدوّن إعادة الفحص في زيارة المتابعة التالية.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، إذا كان طرف السلك يخز خدك فيُرجى وضع شمع التقويم عليه. يُرجى عدم قطع السلك بنفسك. سنصحّحه في [اسم العيادة] بتاريخ [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: إذا انغرس السلك في النسيج مع نزف فموعد مبكر.

الحالة 05 خروج السلك القوسي من الأنبوب

التقييم: خرج السلك من الأنبوب؛ هل الطرف الحرّ يخز النسيج؟

البروتوكول

1. أعد إدخال السلك في الأنبوب.
2. افحص سبب الخروج: هل السلك قصير، أم تنشيط زائد؟
3. غيّر السلك عند الحاجة.
4. إذا وُجد طرف حرّ فاثنِه للداخل.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد يكون السلك قد خرج من مكانه في السن الخلفي. إذا كان يخز فيُرجى استخدام الشمع وعدم سحب السلك. موعدك: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: إذا سبّب السلك الحرّ جرحًا فموعد مبكر.

الحالة 06 انكسار السلك القوسي

التقييم: أين انكسر السلك؟ هل القطعة المكسورة متحركة، وهل يوجد خطر بلع؟

البروتوكول

1. أزِل القطع المكسورة.
2. غيّر السلك.
3. دوّن نقطة الكسر؛ إذا تكرر فالسبب تماس العضة أو إجهاد المعدن.
4. افحص مواضع الأسنان مقارنة بالخطة.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد يكون في سلكك كسر. إذا كانت القطع تتحرك فيُرجى عدم محاولة إزالتها؛ استخدم الشمع وقدّم موعدك: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: إذا فُقدت قطعة مع اشتباه بلعها فانظر الحالة 25.

الحالة 07 طرف سلك الرباط يخز

التقييم: هل انقلب طرف الرباط نحو الشفة أو الخد؟

البروتوكول

1. قصّر الطرف واثنِه تحت الحاصرة.
2. افحص بقية الأربطة.
3. افحص التقرّح.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، إذا كان طرف سلك رفيع يخز شفتك فيُرجى وضع الشمع عليه. سنصحّحه في زيارة المتابعة: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: عادةً ليست طارئة.

الحالة 08 فقدان الرباط المطاطي أو السلسلة

التقييم: أي سن بلا رباط؟ هل خرج السلك من الشق؟ هل انفتحت مسافة؟

البروتوكول

1. جدّد الأربطة الناقصة.
2. عند فقدان السلسلة قِس حالة المسافة.
3. إذا تكرر الفقدان فناقش عادات الأكل.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد تكون إحدى الحلقات المطاطية الصغيرة على أسنانك قد سقطت. هذه ليست حالة طارئة. سنجدّدها في زيارة المتابعة بتاريخ [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: عادةً ليست طارئة.

الحالة 09 انزياح النابض المفتوح

التقييم: هل انزلق النابض، وهل يضغط على اللثة أو الخد؟

البروتوكول

1. أعد النابض إلى مكانه أو أزِله.
2. افحص هدف فتح المسافة؛ هل المسافة المفتوحة محفوظة؟
3. افحص مصدّات النابض.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد يكون النابض بين أسنانك قد انزاح عن مكانه. إذا شعرت بإزعاج فيُرجى استخدام الشمع. موعدك: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: إذا انغرس في اللثة مع نزف فموعد مبكر.

المجموعة 03

الألم والأنسجة الرخوة

حالتان

الحالة 10 الألم والحساسية في الأيام الأولى

التقييم: هل هو تنشيط جديد؟ هل الألم في سن واحد أم منتشر؟

البروتوكول

1. ميّز الحساسية المتوقعة عمّا هو غير طبيعي.
2. عند ألم شديد في سن واحد افحص التماس المبكر وحالة اللب.
3. قدّم للمريض إرشادات الطعام اللين ونظافة الفم.
4. المسكّن عند الحاجة بقرار الطبيب؛ لا تُذكر الجرعات في هذه المادة.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، من المتوقع أن تشعر بحساسية في أسنانك خلال الأيام الأولى بعد التنشيط. نوصيك بالأطعمة اللينة. إذا لم يخفّ الألم خلال أيام قليلة أو ازداد في سن واحد فيُرجى تقديم موعدك.

متى تكون طارئة: عند وجود تورّم أو حمّى أو ألم متزايد في سن واحد فقيّمها في اليوم نفسه.

الحالة 11 تقرّح في الخد أو الشفة

التقييم: مقابل أي جزء من الجهاز يقع التقرّح؟ هل توجد قطعة ذات حافة حادة؟

البروتوكول

1. حدّد السبب وأزِله (طرف حاد، خطّاف، جناح الحاصرة).
2. علّم المريض طريقة استخدام الشمع.
3. تابع التقرّح.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد يكون التقرّح في فمك ناتجًا عن احتكاك الجهاز. يُرجى وضع الشمع على موضع الاحتكاك. إذا لم يلتئم التقرّح خلال أيام قليلة فيُرجى تقديم زيارة المتابعة.

متى تكون طارئة: عند وجود تقرّح لا يلتئم أو يكبر فتقييم من الأخصائي المعني.

المجموعة 04

الغرسة المصغّرة

حالتان

الحالة 12 تهيّج حول الغرسة المصغّرة

التقييم: هل يوجد احمرار أو تورّم أو إفرازات حولها؟ هل يُجرى التنظيف؟

البروتوكول

1. نظّف المنطقة وقيّم النسيج.
2. جدّد تعليمات النظافة.
3. إذا كانت تحت التحميل فافحص ثبات الغرسة.
4. سجّل الحالة.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، يُرجى تنظيف النسيج حول الغرسة بعناية بفرشاة ناعمة. إذا ازداد التورّم أو الإفرازات فيُرجى تقديم موعدك.

متى تكون طارئة: عند تورّم منتشر أو حمّى أو إفرازات فتقييم في اليوم نفسه وإحالة عند الحاجة.

الحالة 13 حركة الغرسة المصغّرة أو سقوطها

التقييم: هل الغرسة متحركة أم سقطت؟ هل عُثر على الغرسة الساقطة؟

البروتوكول

1. لا تحمّل الغرسة المتحركة.
2. إذا سقطت فافحص المنطقة؛ وتأكّد من أن الغرسة لم تُفقد.
3. اجعل الميكانيكا في وضع آمن من دون الغرسة.
4. خطّط لقرار إعادة الغرس والموضع الجديد.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد يكون البرغي الصغير في فمك قد سقط أو ارتخى. إذا وجدته فيُرجى الاحتفاظ به وإحضاره في زيارة المتابعة. نوصيك بتقديم موعدك: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: إذا فُقدت الغرسة مع اشتباه بلعها فانظر الحالة 25.

المجموعة 05

الجهاز

6 حالات

الحالة 14 ارتخاء برغي RME أو انفصال الطوق

التقييم: هل يتحرك الجهاز؟ هل يدور البرغي؟ ماذا يقول سجل التنشيط؟

البروتوكول

1. افحص الجهاز والأطواق.
2. عند الحاجة أزِل الجهاز وأعد تثبيته بالإسمنت.
3. أوقف التنشيط وحدّث السجل.
4. قِس مقدار التوسيع.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد يكون جهاز التوسيع في سقف الحلق قد ارتخى. يُرجى التوقف عن تدوير البرغي. نوصيك بتقديم موعدك: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: إذا أصبح الجهاز حرًّا في الفم ففي اليوم نفسه.

الحالة 15 انفصال القضيب عبر الحنك (TPA)

التقييم: هل الانفصال عند اللحام أم عند الطوق؟ هل القضيب حرّ؟

البروتوكول

1. أزِل القطعة الحرّة.
2. قيّم الحاجة إلى الارتكاز؛ وخطّط لحل مؤقت.
3. جدّد الجهاز.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد يكون القضيب في سقف الحلق قد انفصل. إذا كانت القطعة متحركة فأزِلها بعناية أو استخدم الشمع، ويُرجى تقديم موعدك.

متى تكون طارئة: إذا كانت القطعة حرّة مع خطر بلع ففي اليوم نفسه.

الحالة 16 انغراس زرّ Nance في النسيج

التقييم: هل يوجد أثر أو قرحة أو التهاب في مخاطية الحنك؟

البروتوكول

1. أبعِد الجهاز عن النسيج أو أزِله.
2. تابع التئام النسيج.
3. جدّد تعليمات النظافة.
4. خطّط لحل مؤقت للارتكاز.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد يكون الجهاز في سقف حلقك يضغط على النسيج. يُرجى الحفاظ على نظافة المنطقة، وسنقيّمها في زيارة المتابعة: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: عند قرحة لا تلتئم فالأخصائي المعني.

الحالة 17 كسر الجهاز الوظيفي المتحرك

التقييم: أين الكسر؟ هل لا يزال تركيب الجهاز ممكنًا؟

البروتوكول

1. قيّم الكسر؛ وقرّر الإصلاح أو التجديد.
2. إذا تعذّر تركيب الجهاز فدوّن المرحلة التي بلغها العلاج.
3. اطلب من المريض عدم تركيب الجهاز المكسور.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، إذا انكسر جهازك فيُرجى عدم تركيبه والاحتفاظ بالقطع. يُرجى إحضارها في زيارة المتابعة: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: عادةً ليست طارئة؛ الإصلاح في وقت قصير حتى لا يتعطل العلاج.

الحالة 18 انفصال وصلة الجهاز الوظيفي الثابت

التقييم: هل انفصلت الوصلة تمامًا؟ هل الجهاز حرّ في الفم؟

البروتوكول

1. أزِل القطع الحرّة.
2. جدّد الوصلة.
3. افحص حركة فتح الفم.
4. سجّل الانفصالات المتكررة.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد تكون إحدى وصلات الجهاز الثابت على أسنانك قد انفصلت. يُرجى عدم فتح فمك كثيرًا وتقديم موعدك: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: إذا كانت القطعة حرّة ففي اليوم نفسه.

الحالة 19 تهيّج الجلد أو مشكلة في وصلات قناع الوجه

التقييم: هل يوجد احمرار أو جرح في الجلد؟ هل الخطاطيف داخل الفم سليمة؟

البروتوكول

1. عدّل نقاط الضغط.
2. افحص الوصلات داخل الفم.
3. أعد مناقشة مدة الاستخدام ونظامه مع المريض.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، إذا ظهر احمرار في مواضع تماس القناع فسنعدّله في زيارة المتابعة. إذا تكوّن جرح في الجلد فيُرجى التوقف مؤقتًا عن ارتداء القناع وتقديم موعدك.

متى تكون طارئة: عند جرح في الجلد أو علامات عدوى فالطبيب المعني.

المجموعة 06

التثبيت والمصففات

4 حالات

الحالة 20 انفصال المثبِّت اللساني الثابت

التقييم: في أي سن الانفصال؟ هل تحركت الأسنان؟

البروتوكول

1. سجّل الانفصال ومواضع الأسنان.
2. أصلحه أو جدّده.
3. إذا وُجد انتكاس فقِس مقداره.
4. راجع خطة التثبيت (الدليل 2 · دليل التثبيت التقويمي).

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد يكون أحد طرفي السلك الرفيع خلف أسنانك قد انفصل. نوصيك بتقديم زيارة المتابعة حتى لا تتحرك الأسنان: [تاريخ الموعد]. إذا كان لديك مثبِّت شفاف فيُرجى الاستمرار في ارتدائه.

متى تكون طارئة: إذا وُجد وخز وتقرّح فموعد مبكر.

الحالة 21 كسر المثبِّت الشفاف أو Essix أو فقدانه

التقييم: منذ متى لا يُستخدم المثبِّت؟ هل تحركت الأسنان؟

البروتوكول

1. خطّط لطبعة أو مسح ضوئي لمثبِّت جديد.
2. افحص مواضع الأسنان.
3. سجّل مدة الفقدان.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، إذا فقدت مثبِّتك أو انكسر فأنت بحاجة إلى مثبِّت جديد في وقت قصير حتى لا تتحرك الأسنان. نوصيك بتقديم موعدك: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: عادةً ليست طارئة؛ لكن التأخير قد يؤدي إلى الانتكاس.

الحالة 22 كسر مثبِّت Hawley

التقييم: هل الكسر في الأكريل أم في السلك؟ هل لا يزال المثبِّت يستقر في مكانه؟

البروتوكول

1. قرّر الإصلاح أو التجديد.
2. افحص الاستقرار.
3. تأكّد من أن القطعة المكسورة لا تخز النسيج.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، إذا انكسر مثبِّتك فيُرجى عدم تركيبه والاحتفاظ بالقطع. يُرجى إحضارها في زيارة المتابعة: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: عادةً ليست طارئة.

الحالة 23 سقوط الملحق في علاج المصففات الشفافة

التقييم: أي ملحق؟ هل يستقر المصفف في مكانه؟

البروتوكول

1. جدّد الملحق باستخدام القالب.
2. افحص الاستقرار.
3. علّم المريض تقنية نزع المصفف.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، قد يكون أحد النتوءات الصغيرة على سنك قد سقط. يُرجى الاستمرار في ارتداء المصفف؛ وسنجدّده في زيارة المتابعة: [تاريخ الموعد].

متى تكون طارئة: عادةً ليست طارئة.

المجموعة 07

الرضوض والبلع

حالتان

الحالة 24 رضّ سني لدى مريض بالحاصرات

التقييم: أي الأسنان تأثرت؟ هل توجد حركة أو كسر أو انزياح؟

البروتوكول

1. قيّم الأسنان والعظم والأنسجة الرخوة.
2. خذ صورة شعاعية.
3. أزِل القوى النشطة عن السن المصاب.
4. وثّق حيوية السن وضع خطة متابعة (الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان).
5. أحِل إلى الأخصائي المعني عند الحاجة.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، إذا تعرّضت أسنانك لضربة فيجب تقييمها في اليوم نفسه. إذا خرج سن أو قطعة من مكانها فيُرجى الاحتفاظ بها ومراجعة العيادة فورًا.

متى تكون طارئة: عند خروج السن من مكانه أو الكسر أو رضّ الفك ففي اليوم نفسه؛ وخدمة الطوارئ عند الحاجة.

الحالة 25 اشتباه بلع قطعة أو فقدانها

التقييم: أي قطعة ناقصة؟ هل لدى المريض سعال أو ضيق تنفس أو صعوبة بلع؟

البروتوكول

1. افحص داخل الفم بعناية.
2. إذا وُجدت أعراض تنفسية فأحِل المريض فورًا إلى تقييم طبي إسعافي.
3. إذا لم توجد أعراض فسجّل الحالة وخطّط للتقييم الطبي بقرار الطبيب.
4. حدّد سبب سقوط القطعة.

ما يُقال للمريض

السيد/ة [اسم المريض]، إذا كنت تعتقد أنك بلعت قطعة من جهازك وكان لديك سعال أو ضيق تنفس أو صعوبة في البلع فيُرجى التوجّه فورًا إلى أقرب قسم طوارئ. إذا لم توجد أعراض فيُرجى تقديم موعدك؛ وسنقرر معًا كيفية المتابعة.

متى تكون طارئة: الأعراض التنفسية طارئة دائمًا.

النموذج

نموذج تسجيل الطوارئ

نموذج لكل حالة طارئة. انسخه للاستخدام.

تسجيل طارئ 1

المريض

التاريخ

رقم الحالة واسمها

ماذا حدث (بكلمات المريض)

الموجودات

السبب المحتمل

الإجراء المنفّذ

المعلومات المقدّمة للمريض

هل هي حالة متكررة؟

زيارة المتابعة التالية

تسجيل طارئ 2

المريض

التاريخ

رقم الحالة واسمها

ماذا حدث (بكلمات المريض)

الموجودات

السبب المحتمل

الإجراء المنفّذ

المعلومات المقدّمة للمريض

هل هي حالة متكررة؟

زيارة المتابعة التالية

مادة تعليمية. لا تغني عن الفحص السريري ولا عن قرار الطبيب ولا عن رأي الأخصائي.

الخطوة التالية

إذا تكررت الحالة الطارئة فاملأ تحليل السبب الجذري في **«سجل الحالة»**. وإذا رأيت سببًا ميكانيكيًا فافتح **«أطلس حل المشكلات الميكانيكية»**، وللرضوض افتح **الدليل 4 · الرضوض والتحام الأسنان**.